GEMEINSCHAFTSPRAXIS FÜR ALLGEMEINMEDIZIN
Dorothea Jung • Fachärztin für Allgemeinmedizin
Dr. med. Christian Schmidt • Facharzt für Allgemeinmedizin, Flugmedizin | Sandra Rauch • Fachärztin für Innere Medizin
Wilhelm-Busch-Straße 2 • 38542 Leiferde • Telefon: 05373 1814

ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNG UND SOZIALMEDIZINISCHE STELLUNGNAHME

Zur Vorlage bei der BKK firmus (Versorgungsmanagement Krankengeld) und beim Sozialgericht

Patientin: Frau Alina Steinhauer
Geburtsdatum: 01.09.1993
Anschrift: Carl-Goerdeler-Ring 26, 38518 Gifhorn
Krankenkasse: BKK firmus
Versichertennummer: O603571189
Datum der Stellungnahme: 01.10.2026

Maßgebliche somatische Haupt- und Behandlungsdiagnosen der aktuellen Arbeitsunfähigkeit:

- **ICD-10 Z98.8:** Zustand nach sonstigen näher bezeichneten Operationen (Geschlechtsangleichende Großoperation am 23.06.2026)
- **ICD-10 T81.8:** Sonstige Komplikationen bei Eingriffen / ausgedehnte postoperative Wundheilungsstörung und Gewebereaktion
- **ICD-10 R52.2:** Sonstiger chronischer und postoperativer Schmerz (akutes postoperatives Wundschmerzsyndrom)
- **ICD-10 N99.8:** Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen (Zustand nach Rekonstruktion Neovagina)
- **ICD-10 M62.88:** Massive Bewegungseinschränkung des Beckens und Rumpfes / strikte Aufhebung der Sitz- und Stehfähigkeit

1. Behandlungsverlauf & Operationsereignis

Frau Alina Steinhauer befindet sich in meiner kontinuierlichen hausärztlichen Betreuung. Am 22.06.2026 erfolgte die stationäre Aufnahme in der Fachklinik MVZ Dr. Lubos Kliniken München-Pasing zur Durchführung einer hochkomplexen geschlechtsangleichenden Operation (chirurgischer Eingriff am 23.06.2026: Penektomie, beidseitige Orchiektomie, Rekonstruktion von Neovagina und Neovulva). Nach der Entlassung am 19.07.2026 habe ich in unserer Praxis in Leiferde die lückenlose ambulante Weiterbehandlung und Nachsorge übernommen.

2. Medizinische Differenzierung & Eigenständigkeit des Krankheitsbildes

Es wird hiermit ausdrücklich sozialmedizinisch festgestellt, dass die **seit dem 22.06.2026 bestehende Arbeitsunfähigkeit ein eigenständiges, akut-somatisches Krankheitsgeschehen darstellt**. Sie resultiert unmittelbar und primär aus den schweren chirurgischen Wund- und Gewebefolgen des Großeingriffs.

Abgrenzung zur vorangegangenen Arbeitsunfähigkeit (Aussteuerung Januar 2026): Die bis zum 29.01.2026 dokumentierte Arbeitsunfähigkeit beruhte im Wesentlichen auf psychischen und psychosozialen Belastungsreaktionen (Geschlechtsdysphorie, F-Diagnosen). Die aktuelle Arbeitsunfähigkeit ab dem 22.06.2026 ist demgegenüber **rein somatisch-interventionell** bedingt (massives operatives Gewebetrauma im Genito-Anal- und Beckenbereich mit Wundsekretion, Schwellungen und neuropathisch-somatischem Schmerzsyndrom). Eine Gleichsetzung mit der früheren Erkrankung im Sinne einer »bloßen Fortsetzung derselben Krankheit« (§ 48 Abs. 2 SGB V) ist aus ärztlicher Sicht unzutreffend.

3. Leistungsvermögen & Notwendigkeit der Arbeitsunfähigkeit

Die Patientin ist aufgrund der Operationsfolgen derzeit vollständig außerstande, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Eine Sitzfähigkeit ist postoperativ strikt kontraindiziert und anatomisch unmöglich; längeres Gehen oder Stehen führt zu akuten Schmerzspitzen und Wunddehiszenzen. Zudem erfordert die Nachsorge mehrfach tägliche, zeitaufwendige Spülungen, Dilatationen und Wundpflege. Das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist für jegliche körperliche, sitzende oder stehende Tätigkeit vollständig aufgehoben.

4. Prognose & lückenlose Feststellung

Die Arbeitsunfähigkeit wurde seit dem 22.06.2026 lückenlos ärztlich festgestellt und fortgeschrieben. Aus medizinischer Sicht ist eine vollständige Arbeitsunfähigkeit für mindestens weitere 6 bis 8 Wochen zwingend erforderlich, um einen dauerhaften Behandlungserfolg zu sichern und sekundäre Komplikationen zu verhindern.

Leiferde, den 01.10.2026

_____
Ort, Datum

Praxisstempel & Unterschrift der Ärztin:

_____
Dorothea Jung
Fachärztin für Allgemeinmedizin